

Fecha Última Actualización: 25-01-2026 11:34:15

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Arturo Alejandro Alarcón Donoso
Edad : 51a 2m 26d
Dirección : Avda La Bandera

Rut : 12.679.616-1
Fecha Nacto: 30/10/1974
Comuna : San Ramón

N° Archivo : 2214200
Sexo : Masculino
Teléfono : 930503185

N° Epicrisis
469979

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 23/01/2026 06:56

Días Estadía : 2

Unidad de Egreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Egreso : 25/01/2026 11:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Aneurisma aorta toracoabdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INGRESO CIRUGIA VASCULAR

Medicos : HTA

Disección Ao tipo B en 2022, hospitalizado en UCI 15 días,
Fcos: Losartan, espirolactona, carvedilol, amlodipino, ATV

Qx: LCA rodilla derecha

Alergias: no

Habitos: OH ocasional

Paciente con antecedente de disección aorta tipo B diagnosticado el año 2022, en manejo medico. Asintomatico hasta la fecha. Se mantiene en controles con equipo de cirugía vascular.

Ultimo control en septiembre 2025; se describe pseudocoartación con fenestra amplia en descendente distal. Aorta suprarrenal 4.5x4.5cm. Al examen fisico: pulsos femorales simetricos y popliteos. pedio y top izquierdos lig disminuidos

Ingresa de forma electiva para TEVAR el dia 23/01/26, realizado sin incidentes. Paciente se traslada estable a recuperación Evolución postoperatoria favorable , signos vitales estables, se realiza retiro de cateter peridural el 25/01 asi como de invasivos. Diuresis espontanea, sin dolor. Buena tolerancia oral, en condiciones de alta.

Examen fisico 25/01:

EID sitio de punción femoral sin hematoma ni equimosis

Pulso femoral +, pop +, TP y pedio +

EII: femoral +, pop +, TP disminuido y pedio no palpo

Diagnóstico de Egreso

ANEURISMA Y DISECCION AORTICOS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones, signos vitales estables, afebril, sin dolor, diuresis espontanea conservada. Buena tolerancia oral, deambulando.

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 25/01/2026 11:34

Página 1 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:13

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 25-01-2026 11:34:15

Página 2 de 2

GENERAL

Regimen bajo en sal

Reposo relativo, debe caminar evitando reposo en cama por tiempo prolongado.

Mantenga parche limpio y seco.

MEDICAMENTOS

Mantenga medicamentos de uso habitual

Paracetamol 500 mg. 2 comprimidos cada 8 horas por 7 días

Metamizol 300 mg. 1 comprimido cada 8 horas por 5 días si dolor

Celecoxib 200 mg. 1 comprimido cada 12 horas por 5 días si dolor

Aspirina 100 mg. 1 comprimido al día a permanencia (Se extiende receta por 30 días)

Atorvastatina 40 mg día a permanencia (Se extiende receta por 30 días)

CONTROLES

Control en 2 semanas con Dr Goyanechea cirugía vascular. Poli pasillo 11 CDT HSR

Consultar en urgencias si: Fiebre, dolor en sitio de punción que no cede con analgesia, asociado a aumento de volumen y/o salida de sangre o pus. Compromiso de conciencia, dolor torácico intenso o SOS según estime necesario.

Control de patologías crónicas en su consultorio

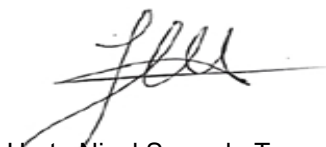
Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles



Herta Nicol Sagredo Torres

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)